Diagnostika ADHD u dospelých: čo je potrebné, aby sa rozptýlenosť nezamenila za diagnózu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Rozptýlenosť má mnoho príčin; diagnózu z nej robí až štruktúrované vyšetrenie a vylúčenie alternatív.

Dospelí s podozrením na ADHD opisujú nepozornosť, zabúdanie, ťažkosti s organizáciou, vnútorný nepokoj alebo impulzivitu. Samotná nepozornosť však diagnózu nezakladá. ADHD je neurovývinová porucha definovaná trvalým vzorcom príznakov s funkčným dopadom vo viacerých prostrediach a s nutnosťou odlíšiť iné medicínske, psychiatrické a environmentálne príčiny. Posudzovacie škály hodnotenie podporujú – nenahrádzajú ho.

Prečo je téma dôležitá aj pre nefrológa

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD; v staršej terminológii MKCH-10 hyperkinetická porucha) sa v dospelosti diagnostikuje čoraz častejšie. Rastie aj počet pacientov, ktorí prichádzajú s vlastným podozrením – často po obsahu na sociálnych sieťach.

Pre nefrológiu je téma relevantná z dvoch strán. Po prvé, **porucha pozornosti je pri chronickej chorobe obličiek (CKD) častá a má viacero medicínskych príčin**, ktoré sa dajú liečiť. Po druhé, ak sa ADHD potvrdí, jeho farmakoterapia zasahuje do krvného tlaku a srdcovej frekvencie – teda presne do parametrov, ktoré sú pri CKD kľúčové.

Cieľom článku nie je nahradiť psychiatrické vyšetrenie. Je ním zhrnúť, čo má obsahovať poctivé diagnostické posúdenie a kde sú jeho hranice.

Čo ADHD v dospelosti je – a čo ním nie je

Diagnóza podľa DSM-5 nestojí na prítomnosti príznakov, ale na ich *vzorci*. Vyžaduje sa:

- trvalý vzorec nepozornosti a/alebo hyperaktivity a impulzivity,
- príznaky nezodpovedajúce vývinovej úrovni,

- prítomnosť vo **viacerých prostrediach** (práca, domácnosť, vzťahy),
- preukázateľné **funkčné poškodenie**, nie iba subjektívny diskomfort,
- počiatok príznakov v detstve,
- vylúčenie iného vysvetlenia.

Klinický obraz sa s vekom mení. Zjavná hyperaktivita spravidla ustupuje, nepozornosť pretrváva. U dospelých sa hyperaktivita často presúva „dovnútra“ – ako vnútorný nepokoj, ruminácie, neschopnosť udržať pozornosť v rozhovore alebo neznesiteľnosť nečinnosti. Ťažkosti s organizáciou, riadením času a emočnou reguláciou sú typické, ale *nešpecifické* – vyskytujú sa pri mnohých iných stavoch.

Diagnostický postup

Zložka	Čo má obsahovať	Váha v rozhodovaní
Klinický rozhovor	aktuálne príznaky, vývinová anamnéza, komorbidity, rodinná anamnéza, funkčné zlyhávanie, kritériá DSM-5	**Základ diagnózy**
Objektívna anamnéza	školské vysvedčenia a hodnotenia, zdravotná dokumentácia z detstva, svedectvo rodiča alebo partnera	Vysoká – najmä pri overovaní počiatku v detstve
Posudzovacie škály	ASRS a podobné nástroje na zmapovanie a kvantifikáciu príznakov	Podporná – nikdy samostatný dôkaz
Štruktúrovaný rozhovor	DIVA-5 alebo iný nástroj viazaný na kritériá DSM-5	Zvyšuje konzistentnosť, nenahrádza anamnézu
Diferenciálna diagnostika	psychiatrické, somatické, liekové a spánkové príčiny	**Povinná**
Neuropsychologické testy	hodnotenie exekutívnych funkcií	Doplnková – normálny výsledok ADHD nevylučuje a abnormálny ho nedokazuje

Posudzovacie škály: čo dokážu a čo nie

Najpoužívanejším nástrojom je **ASRS** (Adult ADHD Self-Report Scale) vyvinutý pod hlavičkou Svetovej zdravotníckej organizácie. Obsahuje 18 otázok podľa kritérií DSM-IV; z nich šesť tvorí skrátený skríner.

Validačná práca Kesslera a spol. na vzorke 154 respondentov porovnala škálu so zaslepeným klinickým hodnotením:

Verzia	Senzitivita	Špecificita	Celková presnosť	Kappa
6-položkový skríner	68,7 %	99,5 %	97,9 %	0,76
18-položková ASRS	56,3 %	98,3 %	96,2 %	0,58

Tieto čísla treba čítať pozorne, pretože hovoria niečo iné, než sa často predpokladá.

Špecificita je vynikajúca, senzitivita nie. Pri 99,5 % špecificite je pozitívny skríning silným signálom, že sa oplatí pokračovať v podrobnom vyšetrení. Pri senzitivite 68,7 % však *zhruba tri z desiatich prípadov ADHD skríner nezachytí*. Negatívna ASRS teda ADHD **nevylučuje** a nesmie byť dôvodom na ukončenie vyšetrovania u pacienta s presvedčivou anamnézou.

Zhoda pri jednotlivých príznakoch navyše veľmi kolísala (Cohenovo kappa 0,16 až 0,81) – niektoré položky teda merajú to, čo klinik hodnotí, podstatne horšie než iné. Paradoxne skrátený šesťpoložkový skríner prekonal plnú 18-položkovú verziu vo všetkých sledovaných parametroch.

Doplňme dve obmedzenia, ktoré sa v propagácii nástroja strácajú: ASRS je viazaná na kritériá **DSM-IV**, nie DSM-5, a validácia prebehla na komunitnej vzorke s cieleným nadzastúpením osôb, ktoré samy uviedli ADHD v detstve. V populácii s inou pretestovou pravdepodobnosťou budú prediktívne hodnoty iné.

Štruktúrované rozhovory: pozor na verziu

DIVA (Diagnostic Interview for ADHD in Adults) je semištruktúrovaný rozhovor, ktorý prechádza kritériá DSM položku po položke a pre každú ponúka konkrétne príklady zo života dospelého aj z detstva.

Pri citovaní dôkazov o nástroji však treba rozlišovať verzie:

- **DIVA 2.0** vychádza z kritérií **DSM-IV**. Práve tejto verzie sa týka najčastejšie citovaná validačná práca (Ramos-Quiroga a spol.) – a išlo o štúdiu na **40 ambulantných pacientoch**, čo je pre posúdenie diagnostickej presnosti veľmi málo.
- **DIVA-5** je aktuálna verzia postavená na kritériách **DSM-5**; existujú aj varianty Young DIVA-5 pre deti a dorast a DIVA-5 ID pre osoby s mentálnym postihnutím. Nástroj spravuje nadácia DIVA Foundation a nie je bezplatný.

Tvrdenie „DIVA je validovaný nástroj“ je preto presnejšie formulovať ako: *DIVA 2.0 bola v malej štúdii validovaná voči kritériám DSM-IV; DIVA-5 je jej aktualizácia podľa DSM-5.*

Diferenciálna diagnostika

Toto je časť, ktorá rozhoduje najviac – a ktorá sa pri rýchlom vyšetrení najčastejšie odbije.

Okruh	Príklady	Rozlišujúci znak
Afektívne a úzkostné poruchy	depresia, generalizovaná úzkostná porucha, bipolárna porucha	epizodický priebeh, ruminácie a anhedónia namiesto celoživotného vzorca
Spánok	spánkové apnoe, nespavosť, syndróm nepokojných nôh, spánková deprivácia	denná spavosť, chrápanie, zlepšenie po liečbe spánku
Látky a lieky	alkohol, kanabis, stimulanciá, abstinenčné stavy; sedatíva, anticholinergiká, antihistaminiká	časová súvislosť s expozíciou
Somatické príčiny	anémia, hypotyreóza a hypertyreóza, deficit B12, poruchy vnútorného prostredia	laboratórny nález, novovzniknuté ťažkosti
Neurologické a kognitívne	mierna kognitívna porucha, demencia, stav po úraze hlavy	progresia, vek nástupu, pamäťový profil
Situačné	vyhorenie, chronický stres, preťaženie, neprimeraná pracovná záťaž	viazanosť na okolnosti, ústup po ich zmene

Kľúčové rozlíšenie: ADHD má celoživotný priebeh s počiatkom v detstve. Novovzniknutá porucha pozornosti u dospelého, ktorý predtým fungoval bez ťažkostí, je *predovšetkým dôvodom na medicínske vyšetrenie*, nie na diagnózu ADHD.

Digitálna distrakcia

Časté prepínanie úloh, krátky obsah a intenzívne používanie smartfónu môžu napodobniť príznaky ADHD. Príčinná súvislosť však nie je preukázaná a smer vzťahu je nejasný: ľudia s poruchou pozornosti môžu obrazovky používať viac, nie naopak. Ide o dôvod na opatrnosť pri interpretácii, nie o diagnostické kritérium ani o vysvetlenie, ktoré ADHD vylučuje.

Prečo je rekonštrukcia detstva metodologicky slabá

Podmienka počiatku príznakov v detstve sa v dospelosti overuje spätne – a spätné vybavovanie je nespoľahlivé. Pacient, ktorý sa už s diagnózou stotožnil, si minulosť prirodzene reinterpretuje cez jej optiku. Dokumentácia z detstva často chýba a rodičia si nemusia pamätať detaily alebo ich hodnotia inak.

Praktický dôsledok: čím slabšie sú podklady o detstve, tým opatrnejší má byť záver – a tým väčšiu váhu má dôsledná diferenciálna diagnostika.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
ADHD nie je dané len nepozornosťou	**Potvrdené**	Vyžaduje sa trvalý vzorec, vývinová neprimeranosť, prítomnosť vo viacerých prostrediach a funkčné poškodenie
Klinický rozhovor je základ diagnózy	**Potvrdené**	V súlade s odporúčaním NICE NG87; štruktúrované nástroje zvyšujú konzistentnosť, nenahrádzajú posúdenie
DIVA je užitočný štruktúrovaný rozhovor	**Potvrdené ako podporný nástroj**	Pozor na verziu: validačná práca sa týka DIVA 2.0 (DSM-IV, n = 40); aktuálna je DIVA-5 (DSM-5)
Posudzovacie škály samy diagnózu nestanovia	**Potvrdené a kvantifikovateľné**	ASRS skríner: špecificita 99,5 %, ale senzitivita iba 68,7 % – negatívny výsledok ADHD nevylučuje
Neuropsychologické testy samy ADHD nedokazujú	**Potvrdené**	Poruchu exekutívnych funkcií spôsobuje množstvo iných stavov; normálny výsledok diagnózu nevylučuje
Úzkosť a depresia môžu príznaky zameniť	**Potvrdené**	Zámena funguje obojsmerne – ADHD býva mylne liečené ako primárna depresia
Spánok, látky a lieky môžu zhoršiť pozornosť	**Potvrdené**	Pri novovzniknutých ťažkostiach majú prednosť pred diagnózou ADHD
Technologická distrakcia môže ADHD napodobniť	**Podporené, kauzalita nejasná**	Smer vzťahu nie je určený; nejde o diagnostické kritérium ani o vylučujúci nález
ADHD v dospelosti nevyzerá ako v detstve	**Potvrdené**	Hyperaktivita ustupuje, nepozornosť pretrváva; príznaky sa internalizujú
Spätné vybavovanie detstva je limitujúce	**Potvrdené**	Bez dokumentácie alebo svedka interpretovať vývinovú anamnézu opatrne

Nefrologické súvislosti

Porucha pozornosti pri CKD má viacero liečiteľných príčin

U pacienta s chronickou chorobou obličiek treba pred úvahou o ADHD cielene zvážiť:

- **kognitívne zmeny pri CKD** – spomalenie, únava, poruchy pozornosti a exekutívnych funkcií sú v tejto populácii dobre popísané a súvisia aj s cerebrálnym ochorením malých ciev,
- **urémiu a metabolické odchýlky** – vrátane vplyvu uremických toxínov,
- **anémiu** pri CKD,
- **poruchy spánku**, ktoré sú pri CKD a najmä pri dialýze veľmi časté (spánkové apnoe, syndróm nepokojných nôh),
- **depresiu a úzkosť** v kontexte chronického ochorenia,
- **polyfarmáciu** – sedatívne, anticholinergné a antihistaminové účinky,
- **interkurentné stavy** – infekcie, dehydratáciu, poruchy iónov,
- **dialyzačný režim** – kolísanie vnútorného prostredia a únavu po procedúre.

Toto nie je alternatíva k ADHD, ale **povinná súčasť** diagnostického procesu. Ak nefrologický pacient žiada vyšetrenie na ADHD, medicínska diferenciálna diagnostika má prebehnúť súbežne s psychiatrickým posúdením.

Ak sa ADHD potvrdí: čo znamená jeho liečba pri CKD

Farmakoterapia ADHD zasahuje do kardiovaskulárnych parametrov. Metaanalýza 22 štúdií so 46 107 účastníkmi potvrdila, že **metylfenidát zvyšuje srdcovú frekvenciu aj systolický tlak** oproti placebu (obe $P < 0,001$) a že u detí a dorastu **atomoxetín zvyšoval tieto parametre ešte viac než metylfenidát**. V počte nežiaducich kardiálnych príhod sa skupiny nelíšili, ale sledovanie bolo krátkodobé.

Pre pacienta s CKD, u ktorého je kontrola tlaku jedným z hlavných nefroprotektívnych opatrení, z toho vyplýva:

1. pred začatím liečby zmerať krvný tlak a srdcovú frekvenciu a zaznamenať východiskový stav,
2. po nasadení a po každej zmene dávky kontrolovať oba parametre,
3. pri vzostupe tlaku prehodnotiť antihypertenzívnu liečbu alebo samotnú indikáciu stimulancia,
4. zohľadniť, že úprava dávkovania pri zníženej funkcii obličiek sa riadi **platným súhrnom charakteristických vlastností konkrétneho lieku** – medzi liečivami sú rozdiely a paušálne pravidlo neexistuje,
5. rátať s tým, že predpisovanie psychostimulancií podlieha na Slovensku osobitným pravidlám pre omamné a psychotropné látky a preskripčným obmedzeniam.

Metaanalýza sa netýkala populácie s CKD, takže veľkosť účinku u týchto pacientov nie je známa. Smer účinku je však konzistentný a opodstatňuje dôslednejšie sledovanie.

Praktický záver

ADHD u dospelých sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť na základe nepozornosti. Poctivé posúdenie kombinuje vývinovú anamnézu (ideálne s doloženým dôkazom z detstva), funkčné poškodenie vo viacerých prostrediach, informácie od blízkych osôb, dôslednú diferenciálnu diagnostiku a posudzovacie škály ako doplnok.

Konkrétne čísla to potvrdzujú: skríningová škála ASRS má síce špecificitu 99,5 %, ale senzitivitu iba 68,7 %. Pozitívny výsledok je dôvod pokračovať, negatívny nie je dôvod skončiť.

Pre nefrologickú prax platí dvojité pravidlo. Pred diagnózou treba vylúčiť medicínske príčiny poruchy pozornosti, ktoré sú pri CKD časté a liečiteľné. Po diagnóze treba pri liečbe sledovať krvný tlak a srdcovú frekvenciu – teda parametre, na ktorých pri CKD záleží najviac.

Súvisiace články

- Chronická choroba obličiek postihuje aj mozog: kognitívne poruchy, cievne poškodenie a klinické dôsledky
- Indoxyl sulfát a kognitívne zhoršenie pri chronickej chorobe obličiek
- Primárna alebo látkou vyvolaná psychóza? Diferenciálna diagnostika a zásady akútnej liečby
- Prukaloprid a „brain fog“ po depresii: môže 5-HT4 agonizmus zlepšiť kogníciu?
- Hraničná porucha osobnosti a telesné zdravie: vyššiu chorobnosť nemožno vysvetliť iba psychikou

Zdroje

1. **Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, Faraone S, Hiripi E, Howes MJ, Jin R, Secnik K, Spencer T, Ustun TB, Walters EE.** *The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population.* Psychol Med. 2005;35(2):245–256. Zdroj údajov o senzitivite, špecificite a kappa. PubMed.
2. **National Institute for Health and Care Excellence (NICE).** *Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management.* NICE guideline NG87. Publikované 14. marca 2018, naposledy aktualizované 13. septembra 2019. Britské odporúčanie, na Slovensku nie je záväzné. Odporúčanie NICE.
3. **Ramos-Quiroga JA, Nasillo V, Richarte V, Corrales M, Palma F, Ibáñez P, Michelsen M, Van de Glind G, Casas M, Kooij JJS.** *Criteria and Concurrent Validity of DIVA 2.0: A Semi-Structured Diagnostic Interview for Adult ADHD.* J Atten Disord. 2019;23(10):1126–1135. doi: 10.1177/1087054716646451. Validácia na 40 ambulantných pacientoch podľa kritérií DSM-IV. Validačná štúdia; PubMed.
4. **DIVA Foundation.** *DIVA-5 — Diagnostic Interview for ADHD in Adults.* Inštitucionálne autorstvo. Aktuálna verzia podľa DSM-5 vrátane variantov Young DIVA-5 a DIVA-5 ID; nástroj je spoplatnený. DIVA Foundation.
5. **Liang EF, Lim SZ, Tam WW, Ho CS, Zhang MW, McIntyre RS, Ho RC.** *The Effect of Methylphenidate and Atomoxetine on Heart Rate and Systolic Blood Pressure in Young People and Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression.* Int J Environ Res Public Health. 2018;15(8):1789. doi: 10.3390/ijerph15081789. Metaanalýza 22 štúdií so 46 107 účastníkmi. Metaanalýza; PubMed.
6. **Medscape Medical News.** *The Challenge of Diagnosing ADHD in Adults.* Medscape, 2026. Sekundárny zdroj použitý ako východisko, nie ako hlavný dôkaz; ako autorka sa uvádza Zebib K. Abraham. Spravodajské spracovanie.

Poznámka k spracovaniu: *Údaje o vlastnostiach škály ASRS (senzitivita 68,7 % oproti 56,3 %, špecificita 99,5 % oproti 98,3 %, celková presnosť 97,9 % oproti 96,2 %, kappa 0,76 oproti 0,58, rozsah kappa 0,16–0,81 pri jednotlivých položkách, vzorka 154 respondentov) boli overené priamo proti abstraktu v PubMed (PMID 15841682), rovnako ako úplný zoznam 12 autorov. Údaje metaanalýzy o metylfenidáte a atomoxetíne (22 štúdií, 46 107 účastníkov, P < 0,001) pochádzajú z abstraktu PMID 30127314; ročník a číslo boli overené cez Crossref. Validačná štúdia DIVA 2.0 (n = 40, kritériá DSM-IV) bola overená cez PMID 27125994 – pozor, týka sa verzie 2.0, nie aktuálnej DIVA-5. Dátumy publikovania a poslednej aktualizácie odporúčania NICE NG87 boli prevzaté priamo zo stránky odporúčania. Autorstvo spravodajského spracovania Medscape sa pre obmedzený prístup nepodarilo nezávisle overiť a uvádza sa s výhradou.*

Poznámka k interpretácii: *Článok neslúži na stanovenie diagnózy ani na výber liečby. Diagnostika ADHD u dospelých patrí do rúk psychiatra; nefrológ prispieva vylúčením medicínskych príčin poruchy pozornosti a sledovaním kardiovaskulárnych parametrov pri liečbe. Dávkovanie liekov pri zníženej funkcii obličiek sa riadi platným súhrnom charakteristických vlastností konkrétneho lieku a preskripčnými obmedzeniami platnými na Slovensku.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=diagnostika-adhd-dospeli-diferencialna-diagnostika · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.